

Пропафенон

Антиаритмик класса IC по Вогану — Уильямсу · слабая β-адреноблокада

ФОРМА ВЫПУСКА

0,35 % · 10 мл = **35 мг**
3,5 мг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Блокада быстрых Na⁺-каналов с медленной кинетикой → замедление проведения в предсердиях, АВ-узле, системе Гиса — Пуркинье; эффект нарастает с частотой. ЭКГ: удлинение PQ, расширение QRS, QT почти не меняется. Метаболизм CYP2D6; T_{1/2} 2,8–11 ч (медленные метаболизаторы — около 17 ч). Ритм восстанавливается в среднем за 2–2,5 ч, амиодароном — за 7–11 ч.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
ФП / ТП < 48 ч, в т. ч. впервые возникшая; нет СН; QRS < 0,12 с	1,5–2 мг/кг (0,4–0,6 мл/кг) в Д5%, за 10 мин	в/в кап. / дозатор
70 кг (пример)	105–140 мг = 30–40 мл (3–4 амп.)	—
Ожидание эффекта	не более 20 мин	—
Альтернатива	прокаинамид 500–1000 мг в NaCl 0,9 % за 20 мин	в/в
ФП > 48 ч или неуточнённой давности	не вводится — урежение ЧСС	
СН, QRS ≥ 0,12 с, ИБС	не вводится — амиодарон 5 мг/кг в Д5%	

Растворитель: только декстроза 5 % (Д5%); NaCl 0,9 % — осадок. **Стоп:** QRS шире на ≥ 25 %, QT длиннее на > 20 %, резкое изменение ЧСС. Макс. 560 мг/сут.

ДОЗАТОР Доза + Д5% до 50 мл → 300 мл/ч = 10 мин. 50 кг: 21–29 мл · 60: 26–34 · 80: 34–46 · 90: 39–51 · 100: 43–57 мл препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Синдром Бругада (седловидный подъём ST в V1–V2, обмороки, внезапная смерть родственников)
- СН, ФВ < 35 %, ОКС, кардиогенный шок (кроме аритмического)
- CCCY, АВ-блокада II–III ст., блокады ножек без ЭКС
- Тяжёлая ХОБЛ, миастения, гипотензия, нарушения калия
- Второй препарат класса IC (аллапинин, этацизин) — риск проведения 1:1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- ФП может перейти в трепетание с проведением 1:1 (ЧСС > 180, широкие QRS) — мониторинг ЭКГ, электроды дефибриллятора в готовности
- β-блокаторы, верапамил: суммация брадикардии и гипотензии
- Повышает дигоксин (доза –25 %), варфарин (МНО), метопролол
- Восстановление ритма фиксируется в карте вызова: сведения значимы для планового лечения